مقدمة :

- انطلاقًا من الحاجة إلى رفع كفاءة المسار **وتحسين جودة البيانات الخاصة بالحالات الإيجابية**، ومع تزايد أعداد المرضى غير المستكملين للإجراءات المطلوبة خلال السنوات الماضية، وما نتج عن ذلك من تراكمات تؤثر سلبًا على جودة المؤشرات ودقة المتابعة، فقد تقرر اعتماد الآلية التالية لضبط وتحسين سير العمل وضمان جودة التعامل مع الحالات:

📌 التوجيهات والإجراءات المعتمدة:

☐ 1 التقييم الأولي

أولًا: دور منسق المسار في القطاع

- يتم **فتح ملف متابعة لكل حالة إيجابية** فور تسجيل نتيجة فحص الدم الخفي في البراز (**ملف متابعة الحالات الإيجابية**).
- يتم التواصل مع الطبيب المعالج وتزويده بمعلومات الحالة ونتيجة الفحص.
- **لا يجوز إدراج** أي حالة إيجابية في ملف SharePoint إلا بعد استكمال هذه الخطوات التنظيمية.

ثانيًا: تقييم الطبيب المعالج

- يُجري الطبيب جلسة توعوية أولية مع المريض.
- يتم تصنيف الحالة بناءً على رغبة المريض في استكمال المسار الطبي **كما يلي:**

- **الحالات الإيجابية الراغبة في الاستكمال:**
  - يُوثق الطبيب تفاصيل الجلسة.
  - يُؤخذ توقيع المريض على نموذج **<u>الإقرار بالموافقة على استكمال المسار</u>** .
  - **المستهدف:** الوصول إلى نسبة ١٠٠٪ من إتمام المسار وإجراء التنظير.
- **الحالات الإيجابية غير الراغبة في الاستكمال:**
  - يُوثق الطبيب رفض المريض في النظام الطبي الموحد (نظام رقيم).
  - تُحال الحالة إلى **مثقف صحي** معتمد لعقد جلسة تثقيفية متخصصة.
  - **لا يجوز إدراج الحالة في SharePoint قبل إتمام الجلسة التثقيفية.**
    - **تهدف الجلسة إلى:**
      - شرح أهمية المتابعة.
      - توضيح أهداف الفحص المبكر لسرطان القولون.
      - بيان المخاطر المحتملة في حال عدم إجراء التنظير.

2 الإجراءات بعد جلسة التثقيف الصحي

- **في حال موافقة المريض بعد التثقيف:**
  - يُؤخذ توقيع المريض على نموذج **<u>الإقرار بالموافقة على استكمال المسار</u>**
  - تُعاد الحالة للطبيب لاستكمال الإجراءات الطبية.
  - يُستكمل ملف المتابعة، مع جدولة زيارة متابعة خلال ٣ أشهر أو بعد إجراء التنظير (أيهما أقرب).
  - **المستهدف:** تحقيق نسبة ١٠٠٪ من إتمام المسار.
- **في حال استمرار الرفض:**
  - يتم إعادة التواصل مع المريض خلال ٧ إلى ١٤ يومًا لمحاولة الإقناع.
  - **في حال استمرار الرفض أو تعذر التواصل رغم المحاولات:**
    - يُؤخذ توقيع المريض على نموذج **<u>إقرار رفض استكمال المسار</u>**
    - يتم توثيق الرفض رسميًا في أحد الأنظمة المعتمدة: (الملف الطبي الموحد ، نظام إحالة ، منصة رقيم)

3 الإدراج الرسمي في SharePoint

- **لا يجوز إدراج أي حالة في ملف SharePoint إلا بعد استكمال كافة الإجراءات التنظيمية أعلاه.**
- الفترات الزمنية المعتمدة للإدراج:
  - 7 أيام عمل كحد أقصى للحالات الراغبة في الاستكمال (من تاريخ أول زيارة للطبيب).
  - 30 يومًا كحد أقصى للحالات الرافضة (من تاريخ أول زيارة للطبيب).
- **يتم تحديث SharePoint بشكل شهري بالتنسيق مع منسق المسار.**

٤⚠ تنويه مهم:

- يُعد إدراج أي حالة قبل استيفاء الخطوات المحددة **مخالفة للآلية**، ويُحمِّل الموظف المعني المسؤولية النظامية الكاملة في حال **حدوث أي ضرر للمريض**- لا قدر الله - **دون وجود توثيق رسمي للرفض.**

أهداف الخطة:

١. رفع كفاءة متابعة الحالات الإيجابية من لحظة اكتشافها حتى استكمال التنظير.
٢. تحسين جودة البيانات المدخلة في النظام وضمان مصداقيتها.
٣. تقليل عدد الحالات المتراكمة وغير المستكملة.
٤. ضبط مؤشرات الأداء لتكون انعكاسًا حقيقيًا لواقع الحالات.
٥. ضمان استمرارية المتابعة الطبية والإدارية للحالات بما يتوافق مع معايير الجودة وسلامة المرضى.

توصيات ختامية:

- ضرورة المراجعة الدورية لملف الحالات الإيجابية لضمان دقة التصنيف والتوثيق.
- تفعيل مؤشرات أداء لقياس مدى الالتزام بالخطة ومخرجاتها.
- تعميم الآلية على جميع الشركاء في البرنامج لضمان التناسق والتكامل في تنفيذ الخطة

قائد مسار الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم

د. محمد سحاري

جوال : 0535752746

إقرار استكمال مسار الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم

بيانات المريض:

- الاسم الرباعي: .....
- رقم الهوية / الملف الطبي: .....
- العمر: ..... سنة
- الجنس: ☐ ذكر ☐ أنثى
- الجهة المحوّل منها: .....
- رقم الجوال للتواصل: .....

<u>نص الإقرار:</u>

أقر أنا الموقع أدناه، بعد اطلاعي على نتيجة فحص الدم الخفي في البراز (FIT) والتي كانت إيجابية، وعلى ضوء الشرح المقدم من الطبيب المختص، بما يلي:

١. **أنني على علم بأن نتيجة الفحص تستدعي استكمال إجراءات الكشف المبكر.**
٢. **أنني وافقت طوعًا على استكمال المسار الطبي، ويشمل ذلك إجراء فحص تنظير القولون في مستشفى الأمير محمد بن ناصر (حفظه الله) .**
٣. **أنني سألتزم بالمواعيد المحددة والتعليمات الطبية والإجرائية.**
٤. **في حال عدم حضوري أو رغبتي في الانسحاب لاحقًا، أتحمل مسؤولية التواصل وإبلاغ الفريق الطبي بذلك.**

اسم المريض / ولي الأمر: .....

التوقيع: .....

التاريخ: ...../...../.....

اسم الطبيب المعالج: .....

التوقيع: .....

التاريخ: ...../...../.....

إقرار رفض استكمال مسار الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم

بيانات المريض:

- الاسم الرباعي: .....
- رقم الهوية / الملف الطبي: .....
- العمر: ..... سنة
- الجنس: ☐ ذكر ☐ أنثى
- الجهة المحوّل منها: .....
- رقم الجوال للتواصل: .....

نص الإقرار:

أقر أنا الموقع أدناه، بأنه /

- تم إبلاغي بنتيجة فحص الدم الخفي في البراز (FIT) والتي كانت إيجابية
- تم شرح أهمية استكمال المسار الطبي بإجراء تنظير القولون، والمخاطر المحتملة عند التأجيل أو الرفض.
- تم **عرض تحويلي لجلسة توعوية** من قبل المدرب / المثقف الصحي

وعلى الرغم من ذلك، فإنني:

☑ **أرفض طوعًا استكمال المسار الطبي المقترح، بما في ذلك إجراءات التنظير والمتابعة.**

☑ **أتحمّل كافة النتائج المترتبة على قراري، وقد تم توضيح ذلك لي بشكل واضح ومفهوم.**

☑ **أعي أن هذا الرفض قد يؤثر على فرص الكشف المبكر والعلاج.**

اسم المريض / ولي الأمر: .....

التوقيع: .....

التاريخ: ...../...../.....

اسم الطبيب المعالج : .....

التوقيع: .....

التاريخ: ...../...../.....

إقرار رفض استكمال مسار الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم

بيانات المريض:

- الاسم الرباعي: .....
- رقم الهوية / الملف الطبي: .....
- العمر: ..... سنة
- الجنس: ☐ ذكر ☐ أنثى
- الجهة المحوّل منها: .....
- رقم الجوال للتواصل: .....

<u>نص الإقرار:</u>

أقر أنا الموقع أدناه، بأنه :

- تم إبلاغي بنتيجة فحص الدم الخفي في البراز (FIT) والتي كانت إيجابية .
- تم شرح أهمية استكمال المسار الطبي بإجراء تنظير القولون، والمخاطر المحتملة عند التأجيل أو الرفض.
- **تم منحي جلسة توعوية** من قبل مدرب صحي معتمد .

وعلى الرغم من ذلك، فإنني:

☑ **أرفض طوعًا استكمال المسار الطبي المقترح، بما في ذلك إجراءات التنظير والمتابعة.**

☑ **أتحمّل كافة النتائج المترتبة على قراري، وقد تم توضيح ذلك لي بشكل واضح ومفهوم.**

☑ **أعي أن هذا الرفض قد يؤثر على فرص الكشف المبكر والعلاج.**

اسم المريض / ولي الأمر: .....

التوقيع: .....

التاريخ: ...../...../.....

اسم المثقف الصحي / مقدم الجلسة: .....

التوقيع: .....

التاريخ: ...../...../.....